안압이 정상이어도 녹내장 관리는 계속됩니다

녹내장(glaucoma)은 시신경이 점차 약해지면서 보이는 범위인 시야가 손상되는 만성질환입니다. 안압 수치와 시신경·시야의 경과를 함께 봅니다.

시력이 괜찮아도 시야 손상이 진행할 수 있습니다



녹내장은 중심 시력이 유지되어도 주변 시야 손상이 진행할 수 있고, 두 눈의 진행 속도가 달라 알아차리기 어렵습니다.

안압 한 번으로 다 판단하지 않습니다

살필 내용	내용과 행동
정상안압녹내장	강의에서 인용한 국내 남일 연구에서는 안압 21mmHg를 기준으로 약 80%가 안압이 높지 않은 녹내장이라고 설명했습니다. "정상"이라는 말이 시신경에도 문제가 없다는 뜻은 아닙니다.
측정의 특성	안압은 각막을 눌러 추정합니다. 각막 두께·곡률의 영향을 받으며 라식·라섹 뒤에는 실제보다 낮게 측정될 수 있습니다.
시간에 따른 변동	안압은 하루 중에도 변합니다. 외래에서 한 번 잰 수치만으로 모든 시간대의 압력을 알 수 없습니다.

시신경과 시야검사를 함께 추적합니다

OCT는 시신경 섬유층 두께 등 구조를, 시야검사는 보이는 범위를 살핍니다. 녹내장은 바깥쪽 시야부터 손상되는 경우가 많고 두 눈의 진행 속도가 달라 늦게 알아차릴 수 있습니다. 연자 Q&A에서는 중증도·진행 속도에 따라 시야검사를 3개월~1년 주기로 하며, 급격한 악화 때는 더 자주 한다고 답했습니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

안약과 정기검사, 꾸준히 이어가세요

안약과 다른 약의 불편함을 알리고, 검사로 경과를 살피며 장기 치료를 이어갑니다.

안약은 진료 직전에만 넣지 않습니다

살필 내용	내용과 행동
치료 목표	시신경에 걸리는 압력을 줄이는 안압하강 치료가 효과가 입증된 치료라고 설명했습니다. 정상 범위 안압에서도 더 낮추는 치료를 할 수 있습니다.
꾸준한 사용	평소 안약을 넣지 않다가 진료 전에만 넣으면 검사 때 안압은 괜찮아도 시야가 나빠질 수 있습니다.
지속 치료와 조정	연자 Q&A: 대부분 평생 사용하지만 아주 초기이거나 오랫동안 진행이 없으면 약을 중단하고 관찰하기도 합니다. 중단 여부는 안과에서 경과를 보며 정합니다.
약으로 부족하면	안약은 대체로 3~4종류까지 사용하고, 잘 써도 악화되면 레이저나 수술을 고려한다고 설명했습니다.

불편하면 약을 바꾸는 과정을 상의합니다

눈의 자극·충혈·눈물·건조

녹내장 안약은 장기 사용하므로 부작용이 적고 효과가 좋은 약에 정착하기까지 여러 번 바꿀 수 있다고 Q&A에서 설명했습니다. 두통도 알리세요.

안약도 전신 상태와 관련됩니다

베타차단제 안약은 심혈관·호흡기 부작용을, 알파2 작용제는 졸림·알레르기를 일으킬 수 있습니다. 프로스타글란딘 계열은 하루 한 번 사용하며 충혈·색소침착·눈 주위 함몰·속눈썹 증가 등이 소개됐습니다.

갑작스러운 안통·시력저하는 즉시 진료

급성 폐쇄각녹내장은 갑작스러운 눈 통증·두통·구토·시력저하로 나타날 수 있습니다. 약을 쓰는 중에도 갑자기 눈이 아프거나 시력이 떨어지면 즉시 안과 진료를 받으세요.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

다른 약·생활 습관도 함께 상의하세요

안약과 다른 약의 불편함을 알리고, 검사로 경과를 살피며 장기 치료를 이어갑니다.

다른 진료·검사 때 녹내장과 안약을 알립니다

살필 내용	내용과 행동
내과약·내시경 전처치	항콜린 작용 약, 일부 감기약·방광약·수면제·항우울제, 토피라메이트 등은 폐쇄각 문제를 일으킬 수 있습니다. 연자는 모든 약을 일괄 금지하기보다 필요한 치료를 판단하고 갑작스러운 안통·시력저하 때 즉시 진료받도록 설명했습니다.
스테로이드	안약·안연고·눈 주위 피부에 사용하거나 전신 고용량·장기간 사용 때 안압이 오를 수 있습니다. 저용량이라도 장기간이면 위험할 수 있고 비강 스프레이 사례도 소개됐습니다.
과거 반응·가족력	스테로이드로 안압이 오른 적, 녹내장·가족력·고도근시를 알리세요. 연자 Q&A에서는 스테로이드 반응자의 비강 스프레이 사용 후 3~4주 무렵 안압을 확인하고 이후 계획은 안과에서 정한다고 설명했습니다.
혈압약·야간 저혈압	연자의 연구에서는 밤에 혈압이 크게 떨어지는 환자에서 진행이 빠른 경향을 보고했습니다. 혈압 치료와 안과 경과를 함께 상의하세요.

생활과 영양제는 이렇게 이해하세요

생활 활동

연자는 근력운동·수영·색소폰·옆으로 자기 등을 일률적으로 제한하지 않으며, 심한 녹내장에서는 오래 하지 않도록 설명했습니다. 흡연·과다 음주는 좋지 않고 카페인·알코올도 과하지 않게 하자고 했습니다.

영양제

녹내장은 영양 부족으로 생기는 병이 아닙니다. 은행잎 추출물 연구, 니코틴아미드 연구를 소개했지만 니코틴아미드 3g/일·칼슘 피루베이트 3g/일 연구 설계를 소개했고, 고용량 니코틴아미드 연구에서 간부전 사례를 언급했습니다. 루테인 효능의 과학적 근거도 미약하다고 Q&A에서 답했습니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 내과 의사가 알아야 할 녹내장 핵심 포인트(성경림)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

집에서 다시 보기